

GUILLAIN-BARRÉ — CVF + IVIG/PLEX

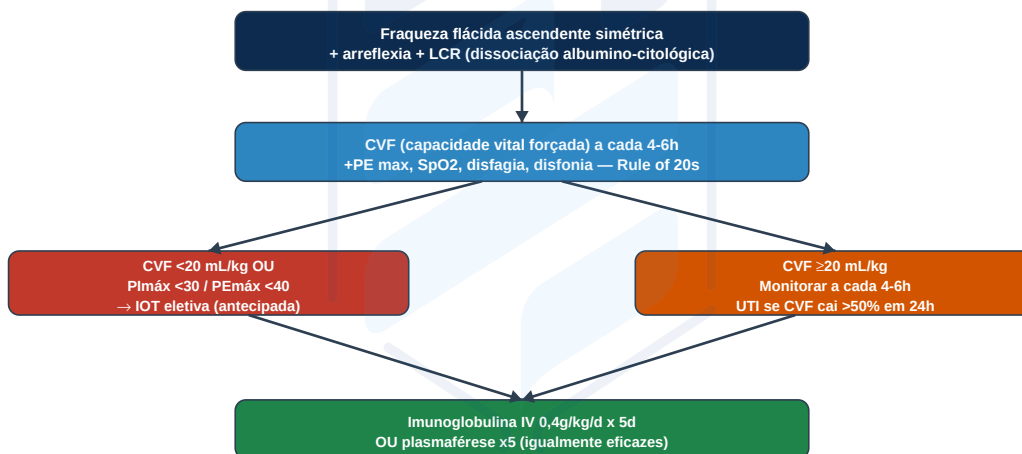
DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

O QUE É SGB

- Polineuropatia inflamatória aguda autoimune — causa mais comum de paralisia flácida aguda no adulto
- Mecanismo: anticorpos contra gangliosídeos do nervo periférico (mimetismo molecular pós-infeccioso)
- Gatilhos: *Campylobacter jejuni* (mais comum, 30%), citomegalovírus, EBV, Zika, vacinas (raro)
- Incidência: 1-2/100.000/ano; pico 50-60 anos e adolescentes; 2x mais frequente em homens
- Mortalidade hospitalar: 3-5% (insuficiência respiratória, disautonomia, sepse)

DIAGNÓSTICO E URGÊNCIA RESPIRATÓRIA

SGB — CVF < 20 mL/kg = IOT URGENTE



CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS — ASBURY/BRIGHTON

Obrigatório (ambos)	Achados de suporte	Contraindicam SGB
Fraqueza progressiva dos membros (MMSS e MMII)	LCR: proteína >45 mg/dL com <10 células (dissociação)	Nível sensitivo definido (lesão medular)
Hiporreflexia ou arreflexia (na maioria)	ENMG: polirradiculoneuropatia aguda (desmielinização ou axonal)	Assimetria marcante
	Progressão por até 4 semanas	Poliomielite, vasculite, outras neuropatias
	Recuperação após platô (semanas-meses)	Diagnóstico alternativo claro

VARIANTES DO GUILLAIN-BARRÉ

Variante	Características	Anticorpo
AIDP (clássica)	Desmielinizante; mais comum no Ocidente; fraqueza ascendente	Anti-GM1, Anti-GM2
AMAN/AMSAN	Axonal; mais comum na Ásia; pós-Campylobacter; pior prognóstico	Anti-GM1, Anti-GD1a
Miller Fisher	Oftalmoplegia + ataxia + arreflexia; prognóstico ótimo	Anti-GQ1b (90%)
Faringocervicobranquial	Disfagia + disartria + fraqueza facial; risco aspiração	Anti-GT1a
Bickerstaff	SNC + SNP: ataxia + oftalmoplegia + alteração consciência	Anti-GQ1b, anti-GM1

REGRA DOS 20s — INTUBAÇÃO ELETIVA

QUANDO INTUBAR (ANTES DA CRISE)

- CVF <20 mL/kg (valor crítico absoluto)
- PImáx <30 cmH₂O (pressão inspiratória máxima)
- PEmáx <40 cmH₂O (pressão expiratória máxima)
- Queda de ≥30% da CVF em 24 horas
- SpO₂ <95% em ar ambiente / incapacidade de tossir
- Disfagia grave com risco de aspiração
- Não esperar SpO₂ cair — intubar ELETIVAMENTE antes da falência

IMUNOGLOBULINA IV vs PLASMAFÉRESE

IgIV (Imunoglobulina IV)

- Dose: 0,4 g/kg/dia IV por 5 dias
- Equivalente à plasmaférese em eficácia
- Mais prático, menos invasivo
- Indicar IgIV se: não deambula, cai rapidamente, VM necessária
- Contraindicação: deficiência de IgA (risco de anafilaxia)
- Monitorar: trombose, IRC (ajuste renal)

Plasmaférese (PLEX)

- 5 sessões em 7-14 dias (ou 4 sessões em SGB leve)
- Remove anticorpos anti-gangliosídeos
- Igualmente eficaz à IgIV
- Pode ser preferida em pacientes com IgA deficiência
- Não combinar IgIV + plasmaférese (sem benefício adicional)
- Complicação: hipotensão, hipocalcemia, infecção do acesso

MANEJO NA UTI — ALÉM DA RESPIRAÇÃO

SUPORTE MULTIORGÂNICO

- ☐ Disautonomia (50%): monitorar PA e FC continuamente; evitar mudanças bruscas
- ☐ Dor neuropática: gabapentina, pregabalina, tramadol — opioides aumentam disautonomia
- ☐ TVP/TEP: heparina profilática (risco alto por imobilidade)
- ☐ Nutrição: SNE se disfagia; medir resíduo gástrico (gastroparesia por disautonomia)
- ☐ Reabilitação precoce: fisioterapia motora e respiratória assim que estável
- ☐ Prognóstico: 85% deambulam em 6 meses; sequelas em 15%; recorrência em 2-5%

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com fraqueza ascendente progressiva, arreflexia e dissociação albumino-citológica no LCR (proteína 120 mg/dL, células 3/mm³). Qual diagnóstico e qual parâmetro monitora o risco de intubação?

- A) Mielite transversa — nível sensitivo
- B) Síndrome de Guillain-Barré — CVF (capacidade vital forçada) seriada
- C) Esclerose múltipla — potenciais evocados
- D) Botulismo — eletromiografia
- E) Polimiosite — CPK

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado no LCR é característico da Síndrome de Guillain-Barré?

- A) Hipoglicorraquia com pleocitose neutrofílica
- B) LCR hemorrágico xantocrômico
- C) Dissociação albumino-citológica (proteína elevada, células normais ou discretamente elevadas)
- D) Tinta China positiva
- E) PCR viral positivo para HSV

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Quando está indicada a intubação orotraqueal eletiva no paciente com SGB?

- A) Apenas quando SpO₂ cai abaixo de 90%
- B) Quando há febre acima de 38,5°C
- C) CVF <20 mL/kg, P_{Imáx} <30, P_{Emáx} <40, ou queda ≥30% da CVF em 24h
- D) Quando o paciente não consegue deambular
- E) Apenas em pacientes acima de 70 anos

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual variante de Guillain-Barré cursa com oftalmoplegia, ataxia e arreflexia, com anticorpo anti-GQ1b positivo?

- A) AIDP clássica
- B) AMAN axonal
- C) Síndrome de Miller Fisher
- D) Variante faringocervicobranquial
- E) Síndrome de Bickerstaff

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é o tratamento imunomodulador de primeira linha na SGB grave que não deambula?

- A) Corticoide IV em altas doses (metilprednisolona 1g/d)
- B) Imunoglobulina IV 0,4 g/kg/dia por 5 dias OU plasmaférese
- C) Ciclofosfamida IV
- D) Interferon beta
- E) Rituximab

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

SGB: fraqueza flácida ascendente + arreflexia + dissociação albumino-citológica no LCR. A CVF (capacidade vital forçada) seriada cada 4-6h monitora o risco de falência respiratória. IOT eletiva se CVF <20 mL/kg.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Dissociação albumino-citológica: proteína elevada (>45 mg/dL, frequentemente >100-200) com celularidade normal ou minimamente elevada (<10 células/mm³). Patognomônica mas não presente na 1ª semana em 10-20% dos casos.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Regra dos 20s: CVF <20 mL/kg, PImáx <30, PEmáx <40 = intubar ELETIVAMENTE antes da crise. Não esperar SpO2 cair — hipóxia na SGB surge tardiamente (intercâmbio gasoso normal até falência muscular grave).

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Miller Fisher: tríade oftalmoplegia + ataxia + arreflexia. Anti-GQ1b positivo em 90%. Prognóstico excelente. Pode ter componente de Bickerstaff (SNC envolvido). Não necessariamente precisa de IgIV se leve.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

IgIV 0,4 g/kg/d x 5 dias ou plasmaférese (5 sessões): igualmente eficazes e indicados em SGB grave (sem deambulação, VM, progressão rápida). Corticoide NÃO tem benefício em SGB (ao contrário da CIDP).

SM24
Suporte ao Plantão Médico